

DOI: 10. 12209/CAIM202401020002

· 中西医结合临床案例 ·

全息经络刮痧治疗1例更年期高血压患者的护理体会

王稷陶¹, 贾宗祎², 孙艳荣¹, 王佳婷¹, 刘 营¹, 郑梦绮¹

(1. 北京中医药大学东方医院 经开区院区 护理门诊, 北京, 100071;

2. 北京中医药大学东方医院 西院区 护理门诊, 北京, 100071)

摘要: 本文总结循经、全息刮痧疗法在1例更年期高血压患者护理中的应用体会。在中医辨证理论指导下,以循证护理导向为基础,采用循经刮痧与全息刮痧,以及病情观察、饮食指导、情志调理等常规护理,对更年期高血压患者进行护理,能达到较理想的护理效果,缩短患者住院时间,改善更年期高血压眩晕等症状,提高生活质量。全息经络刮痧为更年期高血压患者的中西医结合护理提供了一定的依据,值得推广应用。

关键词: 循经刮痧; 全息刮痧; 更年期高血压; 护理

Nursing experience of a patient with menopausal hypertension treated with meridian and holographic scraping

WANG Jitao¹, JIA Zhongyi², SUN Yanrong¹, WANG Jiating¹,LIU Ying¹, ZHENG Mengqi¹(1. Nursing Clinic, Economic Development District, Dongfang Hospital Beijing University of
Traditional Chinese Medicine, Beijing, 100071;2. Nursing Clinic, West Hospital District, Dongfang Hospital Beijing University of Traditional Chinese
Medicine, Beijing, 100071)

ABSTRACT: This article summarizes the experience of the application of meridian and holographic scraping therapy in the care of a patient with menopausal hypertension. Under the guidance of Traditional Chinese Medicine (TCM) syndrome differentiation theory and the evidence-based nursing, the meridian-based scraping and holographic scraping, as well as routine care such as disease observation, dietary guidance, emotional conditioning were applied, which achieved an ideal nursing effect for the menopausal hypertension patient. The above measures also shortened the hospitalization time, improved menopausal hypertension, vertigo and other symptoms, improved the life quality, and provided a therapeutic basis for patients with menopausal hypertension in the combined nursing of TCM medicine, which are worth promoting and applying.

KEY WORDS: Meridian scraping; holographic scraping; menopausal hypertension; nursing

更年期综合征是女性从生殖期过渡到老年期的阶段中由于激素水平变化而产生的一系列躯体心理症状,如潮热多汗、情绪易激惹等^[1]。这些症状严重影响了围绝经期及绝经后女性的生活质量,并且可能进一步提高其老年期罹患老年痴呆、心血管疾病的风险^[2]。

循证导向护理模式是基于循证医学发展而诞生的护理理念,提出护理问题并寻找有价值的、可信的科学研究结果,结合患者实际情况制定有一定针对性、可行性的护理方案,确保患者可获得更科学、合理的护理服务^[3]。全息刮痧疗法是选择

性地刮拭有关的经络穴位和全息穴区,有利于稳定血压,改善头晕等症状,且操作简便,效果显著,无不良反应,患者满意度高。本文总结1例循经全息刮痧疗法治疗更年期高血压患者的护理体会,现报告如下。

1 临床资料

患者为51岁女性,停经半年,主因“头晕3个月,加重1周”,于2023年11月27日由门诊以“高血压”收入院。患者3月前无明显诱因出现头晕,与提问变化无关,偶有头痛,无恶心呕吐,血压最

收稿日期:2024-01-02

OPEN ACCESS

<https://case.jcme.net.cn>

高达到 180/100 mm Hg, 规律口服缬沙坦氨氯地平治疗。患者 3 天前头晕加重, 头痛反复法加重, 为求进一步诊疗收入心内科治疗。入院查体: 体温 36.2℃, 脉搏 87 次/分, 呼吸 19 次/分, 血压 159/94 mm Hg。刻下症: 头晕, 偶有头痛, 无事物旋转, 无事物黑朦, 无意识丧失, 时有心悸, 偶有背部闷痛。纳可, 眠差易醒, 二便调, 舌暗红苔薄白, 脉沉。无既往史。家族史: 母亲高血压病史。中医诊断: 眩晕, 痰瘀互结证。西医诊断: 高血压 3 级(极高危)。诊疗计划: 根据其诊疗常规及名老中医学学术思想, 中医治疗眩晕给予滋生清阳汤加减。西医治疗给予缬沙坦氨氯地平 1 片 1 次/d, 控制血压, 静脉滴注天麻素, 可祛风通络化痰熄风。遵医嘱给予中医特色疗法头部循经、全息刮痧每天一次, 七天一疗程, 并配合相关中西医结合护理措施。治疗一周后患者血压稳定, 波动范围 140~130/90~80 mm Hg 之间, 头晕头痛症状明显改善, 于 2023 年 12 月 3 日出院。

2 护理

2.1 护理评估

2.1.1 中医辨证护理评估: 患者中年女性, 以“头晕”为主症, 当属中医“风眩”范畴。心主神明, 心火旺盛与亏虚皆可影响人体情志, 扰乱正常身体节律。脾脏亏虚致使人体的气血不足, 无法供给足够的气血滋养心脏, 因此心血耗竭, 心气亏损, 造成心神不宁^[4]。患者平素失于调理, 脾胃运化失司, 痰浊内生, 瘀血阻络, 痰瘀上扰, 故见头晕。四诊合参: ①望诊: 精神可, 舌质暗红, 苔薄白; ②闻诊: 言语流利, 对答切题; ③问诊: 无明显诱因出现头晕, 呈阵发性, 每次发作持续时间不等, 时伴有乏力, 血压偏高, 波动范围 160~200/100~140 mm Hg, 口服药物治疗, 血压仍不稳定, 纳可, 眠差易醒, 二便调; ④切诊: 脉弦。该患者为痰瘀互结之证, 病性属本虚标实, 治则以祛痰化浊、活血通络。

2.1.2 结合患者实际, 护理风险评估具体如下。

- ①采用数字分级法(NRS)对病人疼痛程度进行评估。该病例病人 NRS 评分为 4 分, 属于中度疼痛。
- ②焦虑自评量表(SAS)评分 63 分, 属中度焦虑。
- ③采用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评估睡眠质量, 评分越高睡眠质量越差, 分值 0~21 分, 该病例病人 PSQI 为 19 分。
- ④Kupperman 更年期量表进行评估, 该病例病人 Kupperman 评分为 19 分。
- ⑤采用 2010 年《中国高血压防治指南》建议的标

准高血压分级进行血压分级评估, 该病人血压波动在 170~180/110~115 mm Hg, 为 3 级高血压。

2.2 护理诊断

根据患者主诉及中医辨证护理评估, 该患者的护理诊断如下: ①舒适度的改变与头晕: 与痰浊内生、痰瘀互结证有关; ②焦虑与血压过高、头晕有关; ③有心血管意外发生的危险与血压高有关。

2.3 护理计划

根据患者存在的护理问题, 明确护理目标, 制定个体化的护理计划。①给予常规护理, 包括病情观察、生活起居、饮食指导、情志调理、用药指导等方面, 同时提高患者高血压疾病相关知识, 增强患者战胜疾病的信心。②遵医嘱给予循经、全息刮痧疗法以降低、稳定血压, 改善头晕等临床症状, 有效规避跌倒风险。

2.4 护理措施

2.4.1 病情观察: 进行血压监测并做好记录; 密切观察患者头晕发作的次数、持续时间、伴随症状及血压变化; 若出现血压持续上升或伴有眩晕加重, 立即报告医生。

2.4.2 生活起居: 病室保持安静, 舒适, 空气新鲜, 光线不宜过强。眩晕轻者可适当休息, 不宜过度疲劳。眩晕急性发作时, 应卧床休息, 闭目养神, 减少头部晃动, 切勿摇动床架, 症状缓解后方可下床活动, 动作宜缓慢, 防止跌倒。

2.4.3 饮食指导: 指导患者清淡低盐低脂饮食, 每日食盐量<6 g; 限制饮酒及刺激性饮料, 如可乐、浓茶等; 该患者症状属于痰瘀互结型, 饮食以清淡为主, 少食肥甘厚腻、生冷荤腥; 多吃蔬菜、水果, 少量多餐, 不宜过饱, 可配合食疗, 如荷叶粥。

2.4.4 情志调理: 多与患者沟通, 了解其心理状态, 进行针对性指导。眩晕较重, 心烦焦虑者, 减少探视人群, 给患者提供安静的休养空间; 鼓励患者听舒缓音乐, 分散注意力。此外, 多向患者介绍有关疾病知识及治疗成功的经验, 增强患者信心, 鼓励患者积极面对疾病。

2.4.5 用药指导: 遵医嘱予中药汤剂以化痰化浊、活血化瘀, 嘱其早晚温热服, 与西药间隔 1 h; 给予天麻素注射液活血化瘀; 指导患者改变体位时动作需缓慢, 预防直立性低血压的发生, 如果出现头晕、眼花、恶心欲吐等应立即平卧。

2.4.6 头部循经刮痧疗法: 根据头部经络循行, 依次对督脉、膀胱经、胆经进行梳刮, 循督脉和膀胱经刮拭, 发挥疏肝理气、醒神开窍、镇静安神的作用。

用;循胆经刮拭可发挥活血化瘀、醒脑开窍、疏通经络的作用,利于头晕症状的改善^[5]。头部刮拭时要以百会为中心,放射状向四周刮拭,在颞三片部位3段式刮拭,由发际线前额角头维穴刮至风池、风府,最后从左向右垂直刮拭项丛部位。全息穴区:头部的顶后斜带(双侧)、顶枕带上1/3、手部第三掌骨及第二掌骨的颈部区域。全息穴区定位包括:①头部顶后斜带:百会与络却穴连线的两侧旁开0.25寸之间的条带;②顶枕带:百会与脑户穴连线的两侧旁开0.5寸之间的条带;③手部第三掌骨颈椎区:指骨背侧近桡侧的第三掌骨附近及掌骨背侧远端,约占整个掌骨体的1/5^[6]。刮拭时用力轻柔、均匀,以患者感头部微微发热为度。每穴区刮痧10次,刮痧时间持20 min左右,在刮痧期间根据患者耐受程度,调整力度^[7]。

2.5 护理评价

干预7天后,患者自诉头晕等症状明显好转,头痛缓解,NRS评分由4分降至1分,头痛基本得到缓解;焦虑自评量表(SAS)评分54分(属轻度焦虑),患者焦虑有所缓解;匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评估睡眠质量,患者睡眠评分为12分,睡眠障碍症状得到缓解,每日有效睡眠时间有所延长。Kupperman更年期量表评分由25分降为18分,患者更年期症状有所好转。血压保持在140~130/90~80 mm Hg。

3 结果与随访

通过1个疗程的治疗干预后,患者血压控制在140/90 mm Hg以下,头痛头晕症状缓解,无焦虑、睡眠形态紊乱,住院期间未发生跌倒及心血管意外,遵医嘱出院。指导患者可自己刮梳经络以及穴位按摩,做到更好的延续护理。出院后一周、一个月予电话随访,患者血压波动在130~140/85~90 mm Hg之间,无头痛头晕。

4 讨论

更年期高血压是临床的常见病。更年期高血压伴眩晕的患者既要控制血压还需改善眩晕^[8]。但是,目前治疗更年期眩晕症的方法比较有限,主要方法包括西药、中药治疗,针灸和心理治疗等^[9-10]。大多数治疗方案都涉及药物治疗,且效果不佳^[11]。由于西医治疗毒副作用大、依赖性高、远期疗效较差,近几年中医治疗更年期高血压凸显出一定的优势。基于女性更年期高血压住院患者

的临床特点,单纯地解决血压的问题并不能让患者的症状得到改善,为此类住院患者提供恰当的非药物治疗是首要干预方法。医护应在早期就对更年期高血压患者的眩晕等症状进行干预。采用系统化的中医护理措施干预、辨证施护,使患者在控制血压、改善睡眠质量的同时,其他症状亦得到改善。

笔者对更年期高血压患者实施循经、全息刮痧疗法,发现经1周的治疗干预后,循经、全息刮痧疗法可较好地辅助降低血压,改善患者临床症状。刮痧最早见于《痧胀玉衡》:“刮痧法……用铜钱蘸香油刮之”,具有开腠理、行气血、通经络、散毒邪的作用。从现代医学角度来看,刮痧可降低血液黏稠度,改善血管紧张度和黏膜的通透性,加快局部血液循环,降低血压。曾维轲等^[12]通过观察发现,刮痧可改善原发性高血压患者主要中医症状,降低血压,可见刮痧对于高血压病的防治和血压控制有一定的积极作用。刮痧是通过对人体经络进行刮拭,刺激穴位,以调和周身气血,排出脏腑秽浊之气,促进微循环的改善,对高血压病具有良好的调节功效^[13]。生物全息理论是由山东大学张颖清教授提出,该理论反映了整体之象。人体的每一个相对独立的部分称为“全息胚”,其内部不仅有相对完整的结构和功能,而且还能反映整体的功能信息^[14]。在此基础上,张秀勤教授根据传统的经络刮痧方法和自己的临床经验,将生物全息理论与传统刮痧方法相结合,全息经络刮痧法由此被创造性地提出并应用于临床^[15]。现代医学对全息刮痧机制的研究证明,使用刮板刮拭人体相应的全息区和经络穴位对疾病有治疗作用。头面为人之首,头为诸阳之会,脑为元神之府,主明则下安,头部作为一个全息器官,刮拭头部循行经脉,对五脏六腑有调节功能,因此头部刮痧的重要性不容忽视。

基于中医辨证论治理论及更年期高血压病临床辨证结果,制定痰瘀互结型高血压患者的辨证刮痧方案,依据督脉、足太阳膀胱经、胆经等,顺着经脉循行方向进行推刮、揉刮、梳理、放松,以患者能耐受为度,有针对性的调整机体阴阳平衡以及运用生物全息论刮拭体表的全息穴区,不仅能够调理局部气机,而且可以对机体进行全面的调节^[16]。在此基础上可以更加松弛肌肉、缓解精神紧张和刺激血液循环、活血化瘀,从而进一步地改善患者的脑部血液循环,达到治疗的目的。

综上所述,循经、全息刮痧疗法具有无创、简便、有效的特点和优势,可提高临床疗效;且不良反应少,安全性较高,作为中医特色护理技术具有很好的临床推广价值。

患者知情同意:病例报告公开得到患者或家属的知情同意。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。

参考文献

- [1] 谢幸,孔北华,段涛. 妇产科学[M]. 9版. 北京:人民卫生出版社, 2018: 353-356.
XIE X, KONG B H, DUAN T. Obstetrics And Gynecology[M]. 9th Edition. Beijing: People's Health Publishing House, 2018: 353-356.
- [2] NAMSTHE 2017 HORMONE THERAPY POSITION STATEMENT ADVISORY PANEL. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society [J]. Menopause, 2017, 24(7): 728-753.
- [3] 章艳,刘永侠,任娜. 循证干预措施对高危产妇产后抑郁症应用效果及心理状态分析[J]. 贵州医药, 2020, 44(2): 313-314.
ZHANG Y, LIU Y X, REN N. Effect of evidence-based intervention on postpartum depression in high-risk women and analysis of their psychological state [J]. Guizhou Med J, 2020, 44(2): 313-314. (in Chinese)
- [4] 张勇,赵强. 运周推腹法治疗心脾两虚型失眠的临床疗效观察[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(10): 6250-6253.
ZHANG Y, ZHAO Q. Clinical observation on the treatment of insomnia with deficiency of heart and spleen by Yunzhou Tuifu method[J]. China J Tradit Chin Med Pharm, 2021, 36(10): 6250-6253. (in Chinese)
- [5] 侯媛媛,张慧,孙雯. 头部循经刮痧配合重复经颅磁刺激用于紧张型头痛的疗效评价[J]. 陕西中医药大学学报, 2022, 45(4): 101-104.
HOU Y Y, ZHANG H, SUN W. Therapeutic evaluation of scalp scraping along meridian combined with repetitive transcranial magnetic stimulation for tension headache[J]. J Shaanxi Univ Chin Med, 2022, 45(4): 101-104. (in Chinese)
- [6] 张秀勤. 全息经络刮痧疗法[M]. 北京: 新华出版社, 2006.
ZHANG X Q. Holographic Meridian Scraping Therapy[M]. Beijing: Xinhua Publishing House, 2006.
- [7] 徐寒冰,牛琳琳,温鑫,等. 针刺联合循经刮痧治疗原发性高血压的疗效观察及对24 h动态血压的影响[J]. 上海针灸杂志, 2023, 42(5): 459-465.
XU H B, NIU L L, WEN X, et al. Efficacy observation of acupuncture combined with Guasha along meridians for essential hypertension and its impact on 24 h ambulatory blood pressure [J]. Shanghai J Acupunct Moxibustion, 2023, 42(5): 459-465. (in Chinese)
- [8] 宋欣芫,郝洁,肖莉,等. 护理专案改善在提高门诊慢性肾脏病患者自我管理能力中的应用研究[J]. 中华护理杂志, 2017, 52(6): 692-697.
SONG X Y, HAO J, XIAO L, et al. Application of nursing project in improving self-management ability of outpatients with chronic kidney disease [J]. Chin J Nurs, 2017, 52(6): 692-697. (in Chinese)
- [9] 厉钊微,谷雪梅. 杞菊地黄丸联合氯沙坦钾片治疗更年期失眠伴高血压病临床研究[J]. 新中医, 2018, 50(3): 61-63.
LI C W, GU X M. Clinical study of Qiju Dihuang pills combined with losartan potassium tablets for menopause insomnia with hypertension [J]. J N Chin Med, 2018, 50(3): 61-63. (in Chinese)
- [10] 倪元元,汪清晨,张巍,等. 针灸治疗更年期失眠症疗效的Meta分析[J]. 中国妇幼保健, 2021, 36(8): 1942-1946.
NI Y Y, WANG Q C, ZHANG W, et al. Meta-analysis of the curative effect of acupuncture and moxibustion on menopausal insomnia [J]. Matern Child Health Care China, 2021, 36(8): 1942-1946. (in Chinese)
- [11] 刘媛. 二仙汤合甘麦大枣汤对更年期失眠女性睡眠质量的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5(17): 137-139.
LIU Y. Effect of Erxian Decoction and Ganmai Dazao Decoction on sleep quality in menopausal women with insomnia [J]. Clin Res Pract, 2020, 5(17): 137-139. (in Chinese)
- [12] 曾维轲,潘晓彦,雷建兰,等. 辨证刮痧方案在原发性高血压病(肝阳上亢证)患者中应用疗效观察[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021, 23(4): 135-138.
ZENG W K, PAN X Y, LEI J L, et al. Application of syndrome differentiation scrapping scheme in patients with primary hypertension (hyperactivity of liver-Yang type) [J]. J Liaoning Univ Tradit Chin Med, 2021, 23(4): 135-138. (in Chinese)
- [13] 李洪英,宋润娣. 全息刮痧配合穴位贴敷联合中医

- 特色护理治疗眩晕病肝阳上亢证临床观察[J]. 中国中医药现代远程教育, 2020, 18(3): 120-122.
- LI H Y, SONG R D. Clinical Observation of Holographic Scraping Combined with Acupoint Application and Traditional Chinese Medicine Characteristic Nursing in the Treatment of Vertigo of upper Hyperactivity of Liver Yang Syndrome[J]. Chin Med Mod Distance Educ China, 2020, 18(3): 120-122. (in Chinese)
- [14] 罗列娜. 刮痧疗法的研究进展[J]. 中医药导报, 2008, 14(4): 84-85.
- LUO L N. Study progress of scraping therapy [J]. Guid J Tradit Chin Med Pharm, 2008, 14(4): 84-85. (in Chinese)
- [15] 罗秀媚, 陈翠清, 陈丽醒, 等. 全息经络刮痧疗法对维持性血液透析高血压患者全天动态血压水平的影响观察[J]. 湖北中医杂志, 2018, 40(3): 29-30.
- LUO X M, CHEN C Q, CHEN L X, et al. Effect of holographic meridian scraping therapy on ambulatory blood pressure level in patients with hypertension on maintenance hemodialysis [J]. Hubei J Tradit Chin Med, 2018, 40(3): 29-30. (in Chinese)
- [16] 杨敏, 岳容兆, 张沁, 等. 基于文献计量学探析单一刮痧疗法的临床病症谱[J]. 护理研究, 2019, 33(8): 1320-1324.
- YANG M, YUE R Z, ZHANG Q, et al. Analysis of clinical disease spectrum of single scraping therapy based on bibliometrics[J]. Chin Nurs Res, 2019, 33(8): 1320-1324. (in Chinese)
- (本文编辑:王丽瑶)

声明:此案例经过本平台同行评议,全文开放获取,采用知识共享(CC 4.0 BY-NC-ND)许可协议,作者可在其他媒体再次发表。